Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO / IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE	
SERVICIO DE SALUD SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
UNIDAD ASISTENCIAL RESPONSABLE UNITAT ASSISTENCIAL RESPONSABLE	Servicio de Urgencia Hospitalaria
SERVICIO SERVEI	NEUMOLOGIA
NÚM.DE EPISODIO NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO DATA D'INGRÉS	18/07/2021
FECHA Y HORA DE ALTA DATA I HORA D'ALTA	19/07/2021

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT			
PRIMER APELLIDO PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO SEGON COGNOM			
NOMBRE NOM			
CIP DE LA CA CIP DE LA CA		Nº Hª CLÍNICA Nº Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS CODI SNS	
SEXO SEXE	Mujer	F. NACIMIENTO D. NAIXIMENT	
DIRECCIÓN DIRECCIÓ			

Datos generales del paciente / Dades generals del pacient

Procedencia / Procedència: PARTICULAR

Motivo de la atención / Motiu de l'atenció: Remitida para valoración de posible reagudización de EPOC.
En triaje, con O2 con gafas nasales a 1l, mantiene la saturación en valores normales.

Antecedentes / Antecedents:

Ver informe adjunto.

No RAMc
Antecedente de TEP bilatral en 2016, en tratamiento una temporada con Xarelto
Puestas 2 vacunas para SARS-2

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual: Mujer de 82 años que consulta por disnea progresiva desde hace un mes, habiendo de parar al subir las escaleras. Hace una semana, viaje a Francia, tras lo cual, empeoramiento hasta hoy que inicia disnea brusca.
Saturaciones en casa sobre 85%.

Exploración física / Exploració física: 18-07-2021 20:33 - TA: 151/75 mmHg; Tª: 37.5 ºC (Timpánica); FC: 66 lat/min; Sat. O2: 97 %;

REG, consciente, orientada. taquipneica sin oxígeno.
Marcada hipofonesis derecha a la auscultación. Tonos cardíacos ritmicos.

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries: ECG: Ritmo sinusal a 63 lpm, eje cardíaco a 30 º, PR 0.16 , QRS estrecho, no alteraciones de la repolarización.

Gasometría arterial: pH:7.42 pO2:63 pCO2:38 HCO3:25.3

Evolución / Evolució:

COAGULACIÓN
DIMEROS D 466,00 ng/mL (0 - 500)
INDICE DE QUICK 115,0 % (70,0 - 120,0)
INR 0,94 (0,80 - 1,20)
TP RATIO 0,94 (0,80 - 1,20)
TTPA RATIO 0,96 (0,80 - 1,25)
T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV 30,3 seg (25,1 - 32.5)
FIBRINOGENO 375,00 mg/dL (200,00 - 400,00)

HEMOGRAMA
HEMATIES 4,11 x 10^6/µL * (4,20 - 6,10)
HEMOGLOBINA 13,2 g/dL (12,0 - 18,0)
HEMATOCRITO 38,7 %

Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

(37,0 - 52,0)
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO 94,2 fL * (80 - 94)
HBG CORPUSCULAR MEDIA 32,2 pg * (27,0 - 31,0)
CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA 34,2 g/dL (33,0 - 37,0)
RDW-CV 13,0 % (11,6 - 14,5)
LEUCOCITOS 9,80 x 10^3/µL (4,80 - 10,80)
NEUTROFILOS 6,20 x 10^3/µL (1,90 - 8,00)
LINFOCITOS 2,40 x 10^3/µL (0,90 - 5,20)
MONOCITOS 1,10 x 10^3/µL * (0,16 - 1,00)
EOSINOFILOS 0,10 x 10^3/µL (0,00 - 0,80)
BASOFILOS 0,10 x 10^3/µL (0,00 - 0,20)
PLAQUETAS 230 x 10^3/µL (130 - 400)

RX DE TÓRAX: Elevación de Hemidiafragma Derecho ya conocido previamente.Resto no se objetiva condensaciones ni derrame.

Detección antígeno SARS-CoV-2 NEGATIVO

GUARDIA DE NEUMOLOGÍA (Dr.LLopis/Dra. Saravia)
-Avisan para valorar paciente de 82 años de edad,con elevación de Hemidiafragma derecho ya conocida por lo que es usuaria de BIPAP.Que acude a urgencias por disnea a los esfuerzos,que a progresado en el último mes hasta hacerse de mínimos /moderados esfuerzos.Niega tos,niega expectoración,niega fiebre.Niega disminución de la diuresis.Mínima edematización en MMII.
-A nuestra valoración se encuentra clínicamente estable.Eupneica al reposo saturando 95% aa.
AP: MVC sin ruidos sobreagregados.
-Pruebas complementarias con resultados dentro de la normalidad.

->Ante la estabilidad clínica y hemodinámica, se decide alta del SUH para control y seguimiento por su Médico de Familia. Si empeoramiento o nueva sintomatología clínica consultar de nuevo.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal: ELEVACION DIAFRAGMA DERECHO

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta:
Continuar con su tratamiento habitual y añadir:
-Seguril de 40 mgrs, 1 comprimido al día VO. durante 30 días.
-Ventolín 2 puff cada 8 horas con camara espaciadora si precisa.
-Atrovent 2 puff cada 8 horas con camara espaciadora.
-Budesonida 2 puff cada 12 horas con camara espaciadora.
-Seguimiento y control por su MAP
-En caso de signos de alarma consultar de nuevo.

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta: MÉDICO DE CABECERA

Responsable: **Firma digital / Signatura digital:**

ADJUNTO

Sección / Secció: NEUMOLOGIA

Fecha / Data:

Fecha creación / Data creació: 19/07/2021